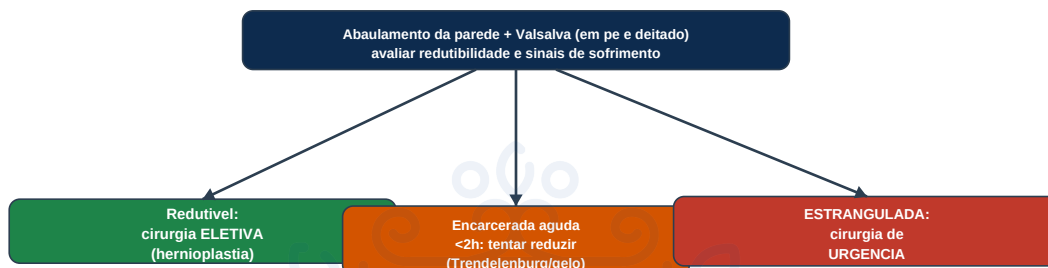


HÉRNIAS — REDUTÍVEL x ENCARCERADA x ESTRANG.

FLUXOGRAMA — A COMPLICAÇÃO GUIA A URGÊNCIA

HÉRNIA — REDUTÍVEL, ENCARCERADA OU ESTRANGULADA



DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E RISCO

O QUE É

- Protrusão de órgão/estrutura através de defeito da parede que o contém; prevalência 3-8%, predomínio masculino
- ~75% são inguinais/femorais; inguinal indireta é a mais comum (homens 9:1); femoral predomina em mulheres e encarcera mais
- Fraqueza da parede: tabagismo, desnutrição, doença do colágeno, diabetes, imunossupressão
- Aumento da pressão intra-abdominal: tosse crônica, obesidade, gestação, prostatismo, ascite, tumores
- Anamnese: abaulamento que piora ao esforço; buscar sinais de OBSTRUÇÃO (náusea/vômito/distensão/parada de eliminação) e de sepse/choque (perfuração por estrangulamento)

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (DEFINE A CONDUTA)

Tipo	Definição / urgência
Redutível	Conteúdo entra e sai pelo orifício; crônica, sem urgência (cirurgia eletiva)
Encarcerada aguda	Irredutível, SEM sofrimento (sem hiperemia/dor intensa) — URGÊNCIA
Encarcerada crônica ('habitada')	Irredutível de longa data, sem sofrimento; geralmente não urgente
Estrangulada	Comprometimento VASCULAR (hiperemia, calor, dor intensa, febre, obstrução) — URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO (EXAMES SE DÚVIDA)

- Diagnóstico CLÍNICO: inspeção em pé e deitado + manobra de Valsalva; examinar todos os sítios (inguinal bilateral, umbilical, incisões prévias)
- Manobra de Landivar diferencia inguinal direta (abaulamento na polpa do dedo) de indireta (na ponta do dedo)
- Imagem só na dúvida (obesos, hérnias gigantes, hidrocele, pubeíte): US (rápido/acessível), TC (diferencial/planejamento), RM (padrão-ouro de planos)
- Laboratório: apenas se complicação ou preparo pré-operatório
- Femoral tem alto risco de encarceramento — baixar o limiar para cirurgia

TRATAMENTO NO PS

Rx ANALGESIA + TENTATIVA DE REDUÇÃO

Analgesia (dipirona/AINE; opioide se dor intensa), gelo local, antieméticos
Encarcerada aguda < 2h SEM sofrimento: pode tentar redução (taxe) — Trendelenburg, gelo, analgesia/opioide e compressão suave
Encarceramento > 2h ou QUALQUER sinal de estrangulamento: NÃO reduzir — avaliação da cirurgia geral
Após redução bem-sucedida: observar (risco de ter reduzido alça em sofrimento) e programar cirurgia
Watchful waiting é aceitável apenas em homens assintomáticos com altíssimo risco cirúrgico

DEFINITIVO / INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ Redutível / perda de domicílio: cirurgia ELETIVA (hernioplastia, geralmente com tela)
- ☐ Encarcerada (irredutível) / estrangulada: cirurgia de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA — contato com plantão de cirurgia
- ☐ Estrangulada: inguilotomia/videolaparoscopia; laparotomia se comprometimento visceral/peritonite/seps
- ☐ ALTA: redutível, sintomas controlados, sem sinais de gravidade -> encaminhar ao cirurgião ambulatorialmente
- ☐ Orientar retorno se dor intensa, abaulamento que não reduz, vômitos, parada de eliminação

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com hérnia ____ (inguinal/femoral/umbilical/incisional); tempo ____; redutível: ____.
- Sinais de estrangulamento (dor intensa, hiperemia, febre) ____; obstrução (vômito/distensão/parada) ____; sinais vitais ____.
- Conduta: analgesia, tentativa de redução (< 2h, sem sofrimento) ____; jejum se cirúrgico.
- Solicito cirurgia geral: eletiva (redutível) OU urgência/emergência (encarcerada/estrangulada).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual achado caracteriza uma hérnia ESTRANGULADA?

- A) Conteúdo que reduz facilmente
- B) Irredutibilidade com comprometimento vascular (hiperemia, dor intensa, febre, sinais de obstrução)
- C) Abaulamento indolor crônico
- D) Redução espontânea ao deitar
- E) Ausência de qualquer sintoma

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento definitivo de uma hérnia inguinal redutível?

- A) Observação por toda a vida
- B) Hernioplastia eletiva
- C) Antibiótico
- D) Faixa abdominal permanente
- E) Cirurgia de urgência sempre

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Hérnia encarcerada há 6 horas, dolorosa, com hiperemia local. Qual a conduta?

- A) Tentar redução manual vigorosa
- B) NÃO reduzir; encaminhar para cirurgia de urgência
- C) Alta com analgésico
- D) Aplicar calor e observar em casa
- E) Faixa compressiva e reavaliação em 1 semana

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual tipo de hérnia tem maior risco de encarceramento, justificando indicação cirúrgica mais precoce?

- A) Inguinal indireta
- B) Femoral
- C) Umbilical em adulto assintomático
- D) Epigástrica pequena
- E) Hérnia de Spiegel

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Em uma hérnia encarcerada aguda (< 2h) sem sinais de sofrimento, o que pode ser tentado no PS?

- A) Redução manual delicada (taxe) com Trendelenburg, gelo e analgesia
- B) Laparotomia imediata
- C) Apenas alta
- D) Antibiótico prolongado
- E) Indução de vômito

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A hérnia estrangulada tem comprometimento vascular do conteúdo (hiperemia, calor, dor intensa, febre, obstrução) — é urgência/emergência cirúrgica pelo risco de necrose e perfuração.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hérnia redutível tem tratamento cirúrgico eletivo (hernioplastia, em geral com tela), pois persiste o risco de encarceramento e a cirurgia eletiva tem menos complicações.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Encarceramento > 2h e/ou sinais de sofrimento (dor intensa, hiperemia) contraindicam a redução: encaminha-se para cirurgia de urgência, evitando reduzir alça já isquêmica.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hérnia femoral encarcera/estrangula com mais frequência (anel estreito e rígido), justificando indicação cirúrgica mais precoce, mesmo quando pouco sintomática.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Na encarcerada aguda recente (< 2h) sem sinais de sofrimento, pode-se tentar a redução manual delicada (taxe) com Trendelenburg, gelo e analgesia, mantendo observação e avaliação cirúrgica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico